SARL TSIFRA
Revue de recherche interdisciplinaire (démo)
Vol. 1, nº 2 (2025)
p. 11–13 · ISSN 0000-0000 (en ligne)

ARTICLE DE RECHERCHE

Recours à la télémédecine chez les personnes âgées dans les petites villes : une étude à méthodes mixtes

Olga Vasilenko[1], **Miroslav Jovanović**[2✉], **Natalia Arkadyeva**[1]

[1] Institut de recherche en santé publique « Vita », Russie
[2] Centre danubien de recherche sur la santé des populations, Serbie
✉ Auteur correspondant: Miroslav Jovanović, m.jovanovic@example.org

Reçu le: 4 mars 2025 **Accepté le:** 15 juillet 2025 **Publié le:** 25 septembre 2025

RÉSUMÉ

Les téléconsultations peuvent améliorer l'accès aux soins pour les habitants âgés des petites villes, où la pénurie de médecins spécialistes est particulièrement aiguë. Le recours à ces services chez les personnes âgées reste toutefois faible, et les raisons en sont mal connues. Cette étude à méthodes mixtes analyse les facteurs associés à l'utilisation de la télémédecine chez les personnes de 60 ans et plus dans quatre petites villes anonymisées. Le volet quantitatif comprenait une enquête téléphonique auprès de 812 répondants ; le volet qualitatif consistait en 28 entretiens semi-directifs avec des patients et 9 entretiens avec des professionnels de santé. Au cours de l'année écoulée, 19 % des répondants avaient eu recours à des services de télémédecine. Dans un modèle logistique multivarié, la probabilité d'utilisation était associée à la possession d'un smartphone, à la cohabitation avec des proches plus jeunes et à la présence de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier, tandis que l'association avec l'âge s'affaiblissait après ajustement sur ces facteurs. Les entretiens ont mis en évidence trois obstacles majeurs : la méfiance à l'égard de l'évaluation à distance de l'état de santé, la complexité des procédures de prise de rendez-vous et d'authentification, et la crainte de faire perdre son temps au médecin en l'absence de consultation en présentiel. Les professionnels de santé ont souligné que la télémédecine est la plus utile pour les consultations de suivi et l'ajustement des traitements. Nous concluons que des interfaces simplifiées et un accompagnement par le personnel infirmier pourraient élargir considérablement le recours à la télémédecine chez les personnes âgées.

Mots-clés: télémédecine; personnes âgées; petites villes; fracture numérique; méthodes mixtes

Telemedicine Uptake among Older Adults in Small Towns: A Mixed-Methods Study

Olga Vasilenko[1], *Miroslav Jovanović*[2✉], *Natalia Arkadyeva*[1]

[1] Vita Research Institute of Public Health, Russia
[2] Danube Centre for Population Health Research, Serbia

ABSTRACT

Telemedicine consultations can improve access to healthcare for older residents of small towns, where the shortage of specialist physicians is particularly acute. However, uptake of such services among older people remains low, and the reasons are insufficiently understood. This mixed-methods study analyses the factors associated with telemedicine use among people aged 60 and over in four anonymised small towns. The quantitative phase comprised a telephone survey of 812 respondents; the qualitative phase consisted of 28 semi-structured interviews with patients and 9 interviews with healthcare workers. Over the past year, 19% of respondents had used telemedicine services. In a multivariable logistic model, the probability of use was associated with smartphone ownership, living with younger relatives and having chronic conditions requiring regular monitoring, whereas the association with age weakened after adjustment for these factors. Interviews revealed three key barriers: distrust of remote assessment of health status, complex booking and authentication procedures, and a fear of wasting the doctor's time without an in-person visit. Healthcare workers noted that telemedicine is most valuable for follow-up consultations and adjusting treatment. We conclude that simplified interfaces and support from nurses could substantially broaden telemedicine use among older adults.

Keywords: telemedicine; older adults; small towns; digital divide; mixed methods

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Pour citer cet article: Vasilenko O., Jovanović M., Arkadyeva N. Recours à la télémédecine chez les personnes âgées dans les petites villes : une étude à méthodes mixtes. *Revue de démonstration sous Open Journal Systems* 2025;1(2):11–13.

1 INTRODUCTION

Les petites villes souffrent d'une pénurie persistante de médecins spécialistes, et les habitants âgés doivent souvent se rendre dans les centres régionaux pour consulter. La télémédecine, sous forme de consultations vidéo ou téléphoniques avec des médecins, a été promue comme un moyen de combler ce déficit, et l'infrastructure des téléconsultations s'est considérablement développée après 2020.

Pourtant, les personnes âgées, qui ont le plus à y gagner, recourent moins à la télémédecine que les autres classes d'âge. Les explications avancées portent généralement sur les compétences numériques, tandis que les attitudes, la situation du ménage et l'organisation des services ont reçu moins d'attention. Cette étude associe des données d'enquête et des entretiens afin de dresser un tableau plus complet du recours à la télémédecine chez les habitants âgés des petites villes.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le volet quantitatif a consisté en une enquête téléphonique assistée par ordinateur menée de mars à mai 2024 dans quatre villes de 18 000 à 45 000 habitants (codées V1 à V4). Un échantillon aléatoire de numéros fixes et mobiles a permis de réaliser 812 entretiens complets avec des habitants âgés de 60 ans et plus (taux de réponse de 37 %). Le principal critère de jugement était le recours à la télémédecine au cours des 12 derniers mois ; les covariables comprenaient les caractéristiques démographiques, l'état de santé, l'équipement en appareils et la composition du ménage.

Dans le volet qualitatif, 28 participants à l'enquête (14 utilisateurs et 14 non-utilisateurs) et 9 professionnels de santé ont pris part à des entretiens semi-directifs. Les transcriptions ont fait l'objet d'une analyse thématique menée indépendamment par deux chercheurs, les divergences étant résolues par la discussion.

3 RÉSULTATS

Au total, 19 % des répondants ont déclaré au moins une téléconsultation au cours de l'année écoulée. Le recours était le plus élevé chez les personnes atteintes de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier (27 %) et le plus faible chez les personnes vivant seules sans smartphone (6 %) (figure 1).

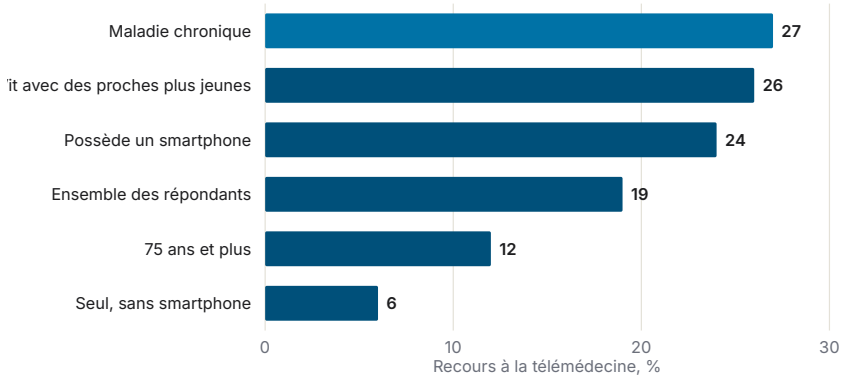


Figure 1. Recours à la télémédecine au cours des 12 derniers mois selon le groupe de répondants, %

Le tableau 1 présente les rapports de cotes ajustés. La possession d'un smartphone multipliait par plus de trois la probabilité d'utilisation, et la cohabitation avec des proches plus jeunes la doublait. L'effet de l'âge s'atténuait et perdait sa significativité statistique après ajustement sur l'équipement en appareils et la composition du ménage.

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Tableau 1. Facteurs associés au recours à la télémédecine (régression logistique, n = 812)

Facteur	RC ajusté	IC à 95 %	p
Possède un smartphone	3.4	2.1–5.5	<0.001
Vit avec des proches plus jeunes	2.0	1.3–3.0	0.001
Maladie chronique, suivi régulier	1.8	1.2–2.7	0.004
Âge (par tranche de 5 ans)	0.89	0.76–1.04	0.140
Femme	1.1	0.8–1.6	0.520

4 DISCUSSION

Les entretiens ont aidé à interpréter ces associations. Les proches plus jeunes jouaient souvent le rôle d'intermédiaires, en prenant les rendez-vous et en configurant les appareils. Les non-utilisateurs exprimaient fréquemment des doutes quant à la capacité d'un médecin à évaluer leur état sans examen, et plusieurs d'entre eux avaient le sentiment qu'une téléconsultation représenterait une charge pour un médecin déjà débordé.

Les professionnels de santé considéraient la télémédecine comme particulièrement utile pour les consultations de suivi et les ajustements de traitement, et suggéraient que le personnel infirmier pourrait aider les patients à se connecter depuis le centre de santé ou à domicile. Ces constats plaident pour des solutions organisationnelles plutôt que purement technologiques.

5 CONCLUSION

Le recours à la télémédecine chez les personnes âgées des petites villes est moins limité par l'âge en lui-même que par l'accès aux appareils, le soutien au sein du ménage et la confiance. La simplification des procédures de prise de rendez-vous et des consultations facilitées par le personnel infirmier constituent des pistes prometteuses pour en élargir l'usage.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017. 492 p.
2. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. Vol. 3, no. 2. P. 77–101.
3. Vasilenko O. P., Arkadyeva N. S. Access to specialist care in small towns: a regional survey // Public Health Perspectives. 2022. Vol. 11, no. 3. P. 201–214.
4. Jovanović M., Petrović S. Digital health literacy among older Europeans // Ageing and Technology. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 15–33.
5. Hale R., Moreno C. Barriers to video consultations in rural primary care: a qualitative synthesis // Rural Health Review. 2022. Vol. 14. P. 88–104.
6. Аркадьева Н. С. Телемедицина в системе первичной медико-санитарной помощи: организационные модели // Здравоохранение и общество. 2023. № 2. С. 26–41.
7. Lindholm K., Saar T. Nurse-facilitated telehealth for older patients: a pilot evaluation // Journal of Community Nursing Research. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 310–322.
8. Vasilenko O. P. Chronic disease monitoring and remote consultations: early evidence // Digital Health Notes. 2023. Vol. 2. P. 40–52.

Diffusé sous licence CC BY 4.0